

Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°149 /MVE-BDBV/10/10/2026

Date du rapport : 10 octobre 2026 Date de publication : 11 octobre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Une évolution favorable de la situation épidémiologique est observée au 10 octobre 2026, marquée par une diminution des nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola (MVE), souche Bundibugyo, à 64 cas contre 69 la veille (−7,2 %) et 102 au 03 octobre (−37,3 %). Ces nouveaux cas proviennent de quatre provinces : l'Ituri (30), le Nord-Kivu (25), le Haut-Uélé (7) et la Tshopo (2).
- La mortalité enregistre également une baisse encourageante, avec 13 décès communautaires contre 30 la veille (−56,7 %) et 19 au 03 octobre (−31,6 %). Les décès enregistrés dans les CTE diminuent à 8 contre 10 la veille (−20,0 %) et 15 au 03 octobre (−46,7 %). Au total, 21 décès ont été rapportés contre 40 la veille (−47,5 %) et 34 au 03 octobre (−38,2 %).
- Sur le plan du diagnostic biologique, 445 échantillons ont été analysés, dont 64 positifs, soit une positivité de 14,4 %, contre 25,9 % au 03 octobre, représentant une amélioration de 11,5 points de pourcentage.

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
8978	4 336	48,3 %	945	2 356	81,0%

Provinces touchées et zones de santé touchées

7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et Sud Ubangi

65 Zones de santé touchées sur 167 (38,9%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Au 10 octobre 2026, les notifications quotidiennes de cas et de décès enregistrent une baisse encourageante. Au total, **64 nouveaux cas confirmés** de la maladie à virus Ebola (MVE) ont été rapportés, contre **69 la veille (−7,2 %) et 102 au 03 octobre (−37,3 %)**. Ils se répartissent entre l'Ituri (30), le Nord-Kivu (25), le Haut-Uélé (7) et la Tshopo (2).

Les décès rapportés diminuent à 21, contre **40 la veille (−47,5 %) et 34 au 03 octobre (−38,2 %)**. Parmi eux, **13 décès communautaires** ont été enregistrés, contre 30 la veille et 19 au 03 octobre, ainsi que **8 décès dans les CTE**, contre respectivement 10 et 15.

Par ailleurs, **18 patients ont été déclarés guéris**, après deux résultats négatifs aux tests de contrôle : 11 en Ituri, 5 au Haut-Uélé et 2 à la Tshopo. Ce nombre est stable par rapport à la veille (18) et légèrement supérieur à celui du 03 octobre (17).

Depuis le début de l'épidémie, la RDC cumule **8 978 cas confirmés et 4 336 décès**, soit une **létalité de 48,3 %**. Au total, **65 zones de santé sur 167 (38,9 %)**, réparties dans sept provinces, ont été historiquement touchées.

Ces évolutions favorables doivent être consolidées par le renforcement du suivi des contacts, de la détection et de la prise en charge précoces, de la prévention et du contrôle des infections et de l'engagement communautaire dans les foyers de transmission active. Il sied de signaler que 12 **ZS ont atteint au moins 42 jours sans nouveau cas confirmé et** 3 ZS se retrouvent entre 22 et 42 jours sans nouveau cas confirmé.

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES CAS ET DÉCÈS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET SITUATION DES ZONES DE SANTÉ, AU 10 OCTOBRE 2026

Province	Nouveaux cas confirmés (24 h)	Cas confirmés cumulés	Décès confirmés cumulés	Létalité	ZS historiquement touchées	ZS actuellement affectées
Ituri	**30**	6 639	3 074	46,3 %	28/36 (77,8 %)	25/36 (69,4 %)
Nord-Kivu	**25**	1 883	1 075	57,1 %	17/34 (50,0 %)	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	**7**	379	159	42,0 %	7/13 (53,8 %)	7/13 (53,8 %)
Tshopo	**2**	59	22	37,3 %	7/23 (30,4 %)	5/23 (21,7 %)
Sud-Kivu	**0**	3	1	33,3 %	1/34 (2,9 %)	0/34 (0,0 %)
Bas-Uélé	**0**	13	4	30,8 %	4/11 (36,4 %)	4/11 (36,4 %)
Sud-Ubangi	**0**	2	1	50,0 %	1/16 (6,3 %)	1/16 (6,3 %)
Total	**64**	**8 978**	**4 336**	**48,3 %**	**65/167 (38,9 %)**	**57/167 (34,1 %)**

Commentaire : Les nouveaux cas diminuent à 64, contre 69 la veille (−7,2 %) et 102 au 03 octobre (−37,3 %). L'Ituri et le Nord-Kivu concentrent 55 cas sur 64 (85,9 %). Parmi les 65 ZS historiquement touchées, 57 restent actuellement affectées selon la situation du 10 octobre ; huit zones de santé historiquement touchées ont franchi un seuil de plus de 42 jours sans nouveau cas. Ces progrès appellent à maintenir la surveillance et à renforcer les interventions dans les foyers actifs.

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 10 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**6639**	**3074**	**46,3%**	**30**	**6**	**3**	**9**
Adja	12	1	8,3%				0
Aru	9	6	66,7%	1	0	0	0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	214	47	22,0%	1	0	0	0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1812	604	33,3%	8	3	0	3
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%				0
Gethy	9	5	55,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	178	107	60,1%	2	0	0	0
Lita	298	151	50,7%	1	1	0	1
Logo	14	7	50,0%				0
Lolwa	35	9	25,7%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	41	17	41,5%				0

Mandima	240	124	51,7%	5	1	0	1
Mangala	369	160	43,4%				0
Mongbwalu	712	341	47,9%	2	0	2	2
Nia-Nia	324	181	55,9%	4	0	0	0
Nizi	809	290	35,8%	3	0	0	0
Nyankunde	133	39	29,3%				0
Rimba	18	5	27,8%				0
Rwampara	1131	393	34,7%	3	1	1	2
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	**1883**	**1075**	**57,1%**	**25**	**5**	**5**	**10**
Beni	442	298	67,4%	5	3	2	5
Biena	23	7	30,4%				0
Butembo	297	185	62,3%	2	0	0	0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	68	26	38,2%	1	1	1	2
Katwa	623	379	60,8%	3	0	0	0
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	37	20	54,1%				0
Lubero	28	12	42,9%	5	1	0	1
Mabalako	62	21	33,9%	6	0	0	0
Alimbongo	5	3	60,0%				0
Manguredjipa	14	5	35,7%	1			0
Masereka	36	12	33,3%		0	1	1
Musienene	143	69	48,3%	1			0
Mutwanga	23	4	17,4%				0
Oicha	39	19	48,7%	1	0	1	1
Vuhovi	39	13	33,3%				0
Haut-Uélé	**379**	**159**	**42,0%**	**7**	**2**	**0**	**2**
Boma Mangbetu	44	19	43,2%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	98	47	48,0%				0
Rungu	4	2	50,0%				0
Wamba	127	45	35,4%	7	2		2
Tshopo	**59**	**22**	**37,3%**	2	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	6	1	16,7%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	32	12	37,5%	2	0	0	0
Mangobo	10	7	70,0%				0
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	0	0	0	0

Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%				0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	**8978**	**4336**	**48,3%**	**64**	**13**	**8**	**21**

Les nouveaux cas confirmés diminuent à 64, contre 69 la veille (−7,2 %), et les décès à 21, contre 40 (−47,5 %). L'Ituri et le Nord-Kivu concentrent 55 cas (85,9 %) et 19 décès (90,5 %). Les notifications sont les plus élevées à Bunia (8 cas), Wamba (7) et Mabalako (6). Les 13 décès communautaires soulignent la nécessité de renforcer la détection et la prise en charge précoces. Aucun nouveau cas n'est rapporté au Sud-Kivu, au Bas-Uélé et au Sud-Ubangi.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées 10 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	87	5	92	15	5	72	0	20	3
Bas Uélé	108	4	112	26	4	82	0	30	0
Ituri	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Nord-Kivu	1 332	69	1 401	187	69	1 145	0	256	138
Sud Ubangi	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	108	0	108	4	0	104	0	4	2
Total Général	**1 635**	**78**	**1 713**	**232**	**78**	**1 403**	**0**	**310**	**143**

L'ensemble des 310 cas suspects validés a été investigué (100 %) parmi les 1 713 alertes rapportées au 10 octobre 2026. Au total, **143 suspects ont été transférés vers les CT/CTE**, soit **61,6 % des 232 suspects vivants**. Le Nord-Kivu concentre 81,8 % des alertes. Ces performances doivent être consolidées par le transfert précoce des suspects

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

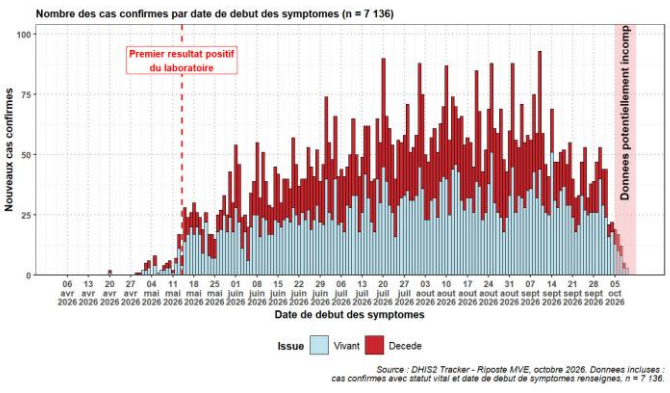
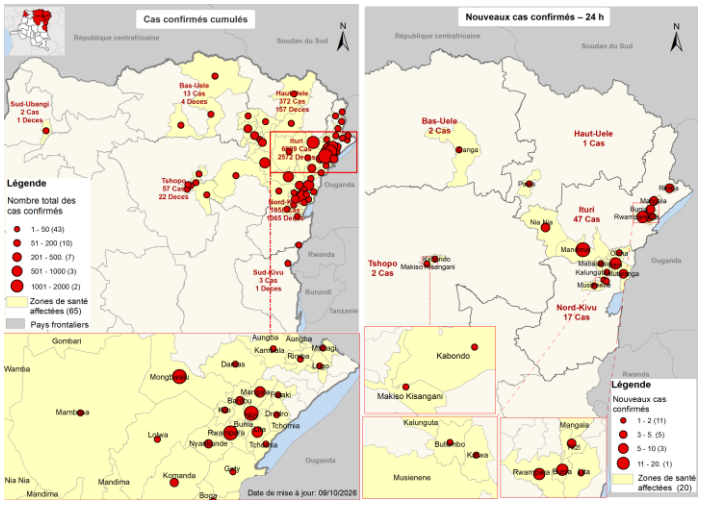


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Tenue de la réunion quotidienne de coordination pour examiner la situation épidémiologique, suivre les activités des piliers, identifier les gaps et définir les priorités opérationnelles.
- Appui aux activités de riposte dans les provinces affectées, à travers les piliers techniques, en fonction des besoins et de l'évolution des foyers de transmission.
- Renforcement de la concertation avec les coordinations provinciales, les autorités sanitaires et les partenaires pour harmoniser les interventions et orienter les ressources vers les zones prioritaires.
- Consolidation et vérification des données provinciales pour améliorer la qualité des rapports et éclairer les décisions opérationnelles.

1.2.Défi majeur

Assurer la mise en œuvre rapide et le suivi des décisions de coordination dans les foyers de transmission active, particulièrement en Ituri et au Nord-Kivu, malgré les contraintes sécuritaires et les besoins logistiques persistants

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Pour le 10 octobre 2026, 1 713 alertes ont été rapportées dans quatre provinces (Nord-Kivu, Haut-Uélé, Bas-Uélé et Tshopo) ; l'Ituri et le Sud-Ubangi n'ont pas transmis de données actualisées (ND). 1 713 alertes ont été vérifiées (97,6 %), dont 310 (18,5 %) ont été validées comme cas suspects. Les 310 cas suspects ont tous été investigués (100,0 %). Parmi eux, 143 (46,1 %) ont été transférés vers les CT/CTE.

Parmi 19 346 contacts en cours de suivi dans les provinces ayant transmis leurs données, 15 672 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de 81,0 %, en baisse par rapport à la veille (83,1 %) et inférieure au seuil requis de 95,0 %. Par province, cette proportion était de 95,1 % (1 843/1 938) au Haut-Uélé, 92,9 % (223/240) au Bas-Uélé, 88,9 % (585/658) à la Tshopo et 78,9 % (13 021/16 510) au Nord-Kivu ; l'Ituri et le Sud-Ubangi n'ont pas transmis de données actualisées (ND). Seul le Haut-Uélé atteint le seuil de 95 %.

2.1.2. Défi majeur

Assurer un suivi quotidien d'au moins 95 % des contacts, particulièrement au Nord-Kivu où cette proportion demeure à 78,9 %, afin de détecter précocement les cas et de limiter les chaînes de transmission. Ce défi s'accompagne de la nécessité d'accélérer le transfert des suspects vivants vers les CT/CTE.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Sept (7) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC le 10 octobre : six (6) en Ituri et une (1) au Nord-Kivu. En Ituri, sur les cinq (5) alertes vivantes validées, une seule a été référée au CTE d'Elikya (PoC Mudzi Bala) ; deux n'ont pas été référées au CTE de Mambasa faute de places et deux patients ont refusé leur transfert. Le corps sans vie d'un nouveau-né intercepté à la Barrière DGDA (ZS de Mahagi) a été swabé (résultat en attente). Au Nord-Kivu, un corps sans vie a été intercepté au PoE de Kasindi et orienté au CSR Lubiriha pour le swab..

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 10 octobre 2026				
Indicateurs	**Ituri**	**Nord-Kivu**	**Tshopo**	**Global**
Complétude des rapports	93,4% (57/61)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	95,0% (95/100)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	140 888	93 282	18 212	252 382
% des voyageurs screenés	97,8%	98,4%	97,8%	98,0%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,7%	98,4%	97,6%	97,9%
% des voyageurs sensibilisés	99,5%	98,4%	100,0%	99,1%
Nombre d'alertes notifiées	6	1	0	7
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	5	0	0	5
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	1	0	2
% des cas suspects transférés au CTE/CT	20,0%	NA	NA	20,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100,0%	100,0%	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	80,0%	NA	NA	80,0%

2.2.2. Défis

Assurer le transfert rapide et effectif des alertes vivantes validées aux PoE/PoC vers les CTE, en levant les obstacles liés au manque de places à Mambasa et aux refus de transfert par un accompagnement communautaire adapté. Renforcer également le suivi des prélèvements et des résultats des alertes décédées pour orienter sans délai les mesures de riposte.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 30 nouveaux résultats positifs** (24 vivants et 6 décès) sur 198 échantillons reçus et analysés **(positivité : 15,2 %) ;**
- **Nord-Kivu : 25 nouveaux résultats positifs** (20 vivants et 5 décès) sur 220 échantillons reçus et analysés **(positivité : 11,4%) ;**
- **Haut-Uélé : 7 nouveau résultat positif (**5 vivants et 2 décès) **sur 13 échantillons reçus et analysés (positivité : 53,8%) ;**
- **Tshopo : 2 nouveaux résultats positifs (2 sangs) sur 7 échantillons reçus et analysés (positivité : 28,6%) ;**
- **Bas Uélé : 7 nouveaux** échantillons reçus (**tous vivants)** tous sont révélés négatifs.

2.3.2. Défi majeur

Maintenir un diagnostic rapide et fiable dans toutes les provinces, en assurant la disponibilité des réactifs, le transport sécurisé des échantillons et la transmission rapide des résultats. Renforcer particulièrement l'appui au Haut-Uélé, où la positivité atteint 53,8 % sur 13 échantillons analysés, pour accompagner l'investigation des foyers de transmission et la prise en charge précoce.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri :** 25 rings ont été ouverts sur 42 (59,5 %), 44 ménages décontaminés sur 60 (73,3 %) et 9 FOSA décontaminées sur 9 (100 %) ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Sur 108 alertes EDS (dont 8 reports de la veille), 70 EDS ont été réalisés (64,8 %) et 82 corps swabés, avec 23 échecs (21,3 %) liés aux résistances à Bambu, Mangala et Mandima ;
- **Nord-Kivu :** 26 rings ont été ouverts sur 36 (72,2 %), avec un gap à Katwa, Mabalako et Beni, 25 ESS décontaminées sur 27 (92,6 %) et 17 ménages sur 43 (39,5 %), aucun des ménages décontaminés n'ayant été doté en kits ; 7 évaluations PCI (score card) ont été réalisées dans 7 ESS avec un score moyen de 37,8 % et aucun PPL n'a été infecté parmi les 17 cas confirmés (0/17). Sur 101 décès attendus (64 alertes et 37 reports), 53 EDS ont été réalisés (52,5 %) et 64 corps swabés sans échec, avec 48 reports au jour suivant ; des kits de lavage des mains ont été distribués dans 52 écoles de 5 AS de la ZS de Beni avec l'appui de CUB/UNICEF ;
- **Haut-Uélé :** 1 ring ouvert sur 1 (100 %) autour du cas de Pawa, 7 ménages décontaminés sur 7 (100 %) et 4 ESS sur 4 (100 %), dont 1 à Isiro et 3 à Pawa ; 6 ESS ont été évaluées au score card (scores de 6,5 % à 56 %, aucune n'atteignant 80 %), 80 prestataires ont été briefés (33 à Pawa, 26 à Isiro, 18 à Wamba et 3 à Boma Mangbetu) et 3 kits PCI de catégorie 3 ont été colisés pour l'AS de Bolebole. Sur 6 alertes EDS, 3 EDS ont été réalisés (50,0 %) et 3 corps swabés ;
- **Tshopo :** 11 ESS sur 11 ont été suivies dans 5 ZS et 142 prestataires briefés sur les précautions standards, le triage et le screening ; le CM Shoukrani (4 locaux et 1 latrine, autour du 57e cas confirmé), la Clinique Kawaki (3 locaux et 1 latrine) et le ménage d'un cas confirmé (10 locaux et 2 latrines) ont été décontaminés. Le cumul provincial atteint 45 rings ouverts sur 45 (100 %) et 34 ménages décontaminés sur 37 (91,9 %) ;

2.4.2. Défis

Assurer la couverture rapide et complète des rings, des décontaminations et des enterrements dignes et sécurisés, particulièrement en Ituri et au Nord-Kivu, en résorbant les reports et en levant les résistances communautaires à Bambu, Mangala et Mandima. Renforcer parallèlement la disponibilité des kits PCI et l'application des mesures de prévention dans les établissements de soins, compte tenu des faibles scores de conformité observés au Nord-Kivu et au Haut-Uélé.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri,** 80 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 59 sorties, dont 11 guérisons, 40 non-cas et 8 décès (dont 3 confirmés). 336 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation des lits de 35,5 % (360/1 015), dont 33 malades critiques ; 345 patients sur 350 (98,6 %) ont reçu un repas chaud et tous les enfants sous LNPE/SLM ont été pris en charge (10/10 au CTE, 6/6 à la crèche et 52/52 dans la communauté) ;
- **Au Nord-Kivu,** 103 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 125 sorties dont 5 guérisons. Au total, 501 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation des lits des CTE/CT de 94,9 %, dont dont 19 malades critiques au CTE de Beni ; 148 patients (31,2 %) sont pris en charge dans des ESS qui ne sont pas des CTE/CT, et 282 malades, 208 accompagnants et 391 PPL ont reçu des repas chauds ;
- **Au Haut-Uélé,** 7 nouvelles admissions (1 confirmé et 6 suspects) ont été enregistrées contre 13 sorties (5 guérisons et 8 non-cas), sans aucun décès. Au total, 68 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation global des lits de 29,4 % (45/153), dont 2 malades sévères ou critiques au CTE de Pawa ; 55 patients, 67 accompagnants et 70 PPL ont reçu des repas chauds ;
- **À la Tshopo,** 1 nouvelle admission (1 suspect) a été enregistrée contre 2 sorties, toutes des guérisons, dont un médecin. Au total, 14 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation global des lits de 30,6 % (11/36), dont 1 malade en état

sévère ; depuis le début, 439 personnes ont reçu le traitement expérimental, dont 40 cas confirmés, et 399 ont bénéficié de la prophylaxie post-exposition ;

- **Au Bas-Uélé,** 26 nouveaux cas suspects ont été admis dans les centres de transit (Buta 6, Bondo 4, Ganga 4, Poko 3, Titule 3, Likati 2, Viadana 2, Aketi 1 et Dakwa 1), sans aucune sortie ; au total, 26 patients sont en isolement et aucun nouveau cas confirmé n'a été admis.

2.5.2. Défis

Garantir une prise en charge précoce, sécurisée et de qualité, en renforçant prioritairement les capacités d'accueil au Nord-Kivu, où l'occupation des lits atteint 94,9 % et 148 patients sont pris en charge hors des CTE/CT. Assurer parallèlement les soins adaptés aux malades sévères et critiques, la continuité de l'appui nutritionnel et psychosocial et l'orientation rapide des patients vers les structures appropriées.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **Au Haut-Uélé,** le cumul atteint 399 PPL vaccinés sur 858 préenregistrés (46,5 %), avec 399 doses de vaccin Ervebo utilisées sur 500 reçues ; la rétrosaisie des données de vaccination dans le DHIS2 Tracker a débuté après la formation des data managers de la DPS, de l'antenne PEV et des ZS ;
- **En Ituri,** la collecte des données de l'étude sur l'impact de l'épidémie de MVE sur l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive s'est poursuivie dans les ZS de Mongbwalu, Bunia, Rwampara, Tchomia et Nyarambe, de même que les enquêtes qualitatives et opérationnelles et les essais cliniques Partners, Oracle et EBO-PEP.

2.6.2. Défis

Accélérer la vaccination des PPL préenregistrés au Haut-Uélé, où la couverture demeure à 46,5 %, en assurant la disponibilité des doses, la mobilisation des personnes éligibles et la complétude des données dans le DHIS2 Tracker. En Ituri, garantir la continuité et la qualité du suivi des études et essais cliniques en cours.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **À la Tshopo,** l'évaluation des Cliniques des Anges de Kisangani (CAKIS) a montré une zone de triage effective, un incinérateur opérationnel et une utilisation systématique du partogramme, mais seulement 6 agents vaccinés contre la MVE sur 21 (28,6 %) ; le plan de redressement du CS RTNC a été élaboré, et le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que celui des guéris présentant des comorbidités à l'HGR de Makiso-Kisangani se sont poursuivis ;
- **Au Nord-Kivu,** l'encodage des évaluations de la continuité des services de santé essentiels dans les ESS de la ZS de Butembo s'est poursuivi ;
- **Au Bas-Uélé,** aucune donnée n'a été transmise par le pilier continuité des soins au cours des dernières 24 heures**.**

2.7.2. Défi majeur

Maintenir l'accès à des services de santé essentiels sûrs et de qualité, en mettant en œuvre les plans de redressement des établissements évalués, en renforçant la vaccination des agents éligibles et en assurant le suivi des guéris présentant des comorbidités. Améliorer parallèlement la disponibilité des données de continuité des soins, notamment au Bas-Uélé, pour orienter les actions correctrices.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri,** 21 339 visites à domicile ont touché 61 212 personnes ; 663 causeries éducatives ont réuni 10 383 personnes, 20 sensibilisations de masse 2 665 personnes, 7 débats communautaires 217 personnes et 11 plaidoyers 19 autorités et leaders ; 28 spots ont été diffusés sur 36 stations de radio et 17 émissions organisées. Au total, 388 alertes communautaires, dont 91 décès, ont été notifiées ; 250 feedbacks sur 282 (88,7 %) et 12

incidents sur 18 (66,7 %) ont été résolus dans les 48 heures, 35 RECO de l'AS de Nzere ont été briefés sur l'approche village et les cellules d'animation communautaire, 44 enseignants et 987 élèves de l'Institut Kibonge (ZS de Komanda) ont été sensibilisés et 151 contacts ont été pré-listés autour de 5 cas confirmés. La complétude des rapports CREC n'est que de 39,3 % (11/28 ZS) ;

- **Au Bas-Uélé,** 2 séances de sensibilisation de masse ont touché 250 personnes dans l'AS de Limba (ZS de Viadana) à travers une caravane motorisée avec le témoignage des guéris, une émission radio a touché 9 650 personnes à Likati, 50 personnes (dont 30 RECO, 10 chefs de base et 10 leaders féminins) ont été briefées à Viadana et 110 personnes sensibilisées à Dakwa ; 4 guéris ont été réinsérés dans la communauté à Viadana) ;
- **À la Tshopo,** 183 visites à domicile ont touché 1 855 personnes, 3 causeries éducatives 173 personnes et 6 séances de sensibilisation de masse au moins 162 000 personnes, notamment à travers une caravane motorisée dans les communes de Makiso, Mangobo, Tshopo, Kabondo et Kisangani ; 30 alertes communautaires ont été notifiées et toutes traitées, le feedback reçu a été résolu (1/1) et 250 apprenants et 15 enseignants de l'ITM Kimbanguiste ont été sensibilisés à Lubunga ;
- **Au Haut-Uélé,** 13 causeries éducatives ont réuni 312 personnes, 3 séances de sensibilisation de masse 1 357 élèves et 45 visites à domicile 225 personnes à Wamba, et 45 RECO de l'AS de Bolebole ont été briefés sur le paquet complet de la MVE, soit 1 939 personnes touchées ; 5 alertes communautaires, dont 4 décès, ont été notifiées à Wamba, les 5 feedbacks reçus ont été résolus (100 %) et 61 membres des familles de 4 décès suspects ont été sensibilisés au suivi des contacts, à la décontamination et à l'EDS ;
- **Au Nord-Kivu,** 10 939 visites à domicile ont touché 31 720 personnes, 610 causeries éducatives 4 478 personnes, 48 communications de masse 4 832 personnes et 5 briefings 184 personnes ; 396 alertes communautaires ont été notifiées sur 650 attendues, 22 feedbacks sur 30 (73,3 %) et 3 incidents sur 6 (50,0 %) ont été résolus dans les 48 heures, des dialogues communautaires impliquant les leaders locaux ont été lancés à Katwa et 51 responsables d'établissements scolaires ont été briefés à Lubero.

2.8.2. Défi majeur

Renforcer l'adhésion communautaire au signalement précoce des alertes, au suivi des contacts, au transfert vers les CTE et aux enterrements dignes et sécurisés, en accélérant la résolution des préoccupations et des incidents, particulièrement en Ituri et au Nord-Kivu. Améliorer parallèlement la complétude des rapports CREC en Ituri, limitée à 39,3 %, afin de mieux cibler les interventions et d'en suivre les résultats.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu,** 16 sur 47 derniers cas confirmés (34,0 %), 68 confirmés en cours de suivi sur 76 (89,5 %), 36 nouveaux suspects sur 60 (60,0 %) et 92 suspects en cours de suivi sur 101 (91,1 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 226 accompagnants et 73 PPL, suivi 21 guéris sur 26 (80,8 %) en communauté et 13 enfants sur 13 en crèche, accompagné 9 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 13, réinséré 6 guéris sur 8, réalisé 1 réunification familiale et annoncé 36 résultats, dont 16 positifs ; 47 enfants sont suivis ;
- **À la Tshopo**, 2 sur 2 derniers cas confirmés (100 %), 4 confirmés en cours de suivi sur 4 (100 %), 2 nouveaux suspects sur 2 et 7 suspects en cours de suivi sur 7 (100 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 3 ménages ont été accompagnés, 4 PPL soutenus, 2 guéris suivis en communauté et réinsérés, 160 personnes ont bénéficié de la psychoéducation et 7 résultats, dont 2 positifs, ont été annoncés ; les 3 résistances notifiées ont été levées et 5 ZS sur 7 ayant notifié sont couvertes ;
- **Au Haut-Uélé,** 3 nouveaux cas confirmés, 23 confirmés en cours de suivi, 6 nouveaux suspects et 28 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les CTE d'Isiro, Pawa, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 31 accompagnants, 63 PPL, 10 enfants séparés en communauté et 9 membres de ménages, appuyé 1 EDS et annoncé 19 résultats, dont 3 positifs.

2.9.2. Défis

Assurer un soutien psychosocial précoce et continu à tous les patients et aux personnes affectées, particulièrement au Nord-Kivu où seuls 34,0 % des derniers cas confirmés et 60,0 % des nouveaux suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS. Renforcer également l'accompagnement des enfants séparés et orphelins, la réinsertion des guéris et la couverture des zones de santé encore non desservies.

2.10. Sécurité

2.10.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, les équipes ont été escortées pour l'enterrement d'un cas confirmé au cimetière de Bundji, la décontamination d'un ménage de l'AS de Kasanga et du dispensaire Arche (AS de Ngongolyo), le swab d'un corps sans vie à la morgue Horizon et l'état des lieux de l'AS de Kambuli (Katwa) avec le partenaire FHI 360 ; une séance de démonstration des pratiques d'EDS a également été organisée à Kambuli avec l'équipe de mitigation des risques.

2.10.2. Défi majeur

Garantir un accès sécurisé et continu des équipes aux zones d'intervention du Nord-Kivu, notamment à Katwa, par une coordination adaptée des escortes, l'anticipation des risques et le dialogue communautaire, afin de réaliser sans retard les investigations, les prélèvements, les décontaminations et les enterrements dignes et sécurisés.

2.11. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.11.1. Principales actions

- **En Ituri,**l la formation des formateurs sur la PSEA-H/AAP, tenue du 06 au 10 octobre 2026 à Bunia, a été clôturée par une évaluation théorique et pratique et la remise des certificats ; 18 personnes (14 femmes, 3 hommes et 1 garçon) ont été sensibilisées sur la PSEA-H et les canaux de signalement (151 et 495555) dans l'AS de Bakoko, et l'affichage des messages et la distribution des dépliants se sont poursuivis à Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki ;
- **Au Nord-Kivu,** des séances de sensibilisation sur la PSEA et le signalement via le 151/495555 ont touché 35 personnes dans l'AS de Mabolio (ZS de Beni), 13 élèves de l'Institut Visonge (ZS de Butembo), 54 personnes du quartier Mabanga (ZS de Mutwanga) et 66 fidèles du quartier Kamina (ZS de Manguredjipa), et le staff PCI de Mutwanga a reçu un rappel sur la lutte contre les inconduites sexuelles. Au Haut-Uélé, 4 membres de l'équipe IMA ont été briefés sur la PSEAH et ont signé le code de bonne conduite à Wamba, et 4 séances de sensibilisation ont été organisées à Boma, Pawa et Isiro en faveur des élèves de l'Institut Malamu, des chauffeurs de la riposte et des relais communautaires.

2.11.2. Défis

Au niveau national, seules 3 DPS sur 7 (42,9 %) ont rapporté leurs activités PSEA (Ituri, Nord-Kivu et Haut-Uélé) ; la proportion de ZS connaissant le mécanisme de signalement reste faible en Ituri (36,1 % ; 13/36), au Nord-Kivu (17,6 % ; 6/34) et au Haut-Uélé (46,2 % ; 6/13), les supports de visibilité sont insuffisants et certains partenaires ne sont pas encore alignés.

2.12. Gestion des bases des données

2.12.1. Principales actions

- Mission de supervision au Nord-Kivu pour accompagner les équipes provinciales et les zones de santé dans l'amélioration de la qualité, de la complétude et de la mise à jour des données de la riposte ;
- Appui à la vérification des enregistrements, à la recherche des doublons et à la correction des incohérences dans les bases de données ;
- Renforcement de la concordance des données entre les piliers surveillance, laboratoire et prise en charge, notamment pour les cas confirmés, les décès et les guérisons ;
- Accompagnement des gestionnaires de données dans l'utilisation du DHIS2 Tracker et le suivi des corrections nécessaires à la production des rapports quotidiens.

2.12.2. Défi majeur

Garantir des bases de données complètes, fiables et actualisées, particulièrement au Nord-Kivu, en assurant la correction des anomalies relevées lors de la supervision, la concordance entre les piliers et la transmission régulière des données pour éclairer les décisions opérationnelles.

MESSAGES CLES

- **Une baisse encourageante des cas et des décès est observée au 10 octobre 2026** : 64 nouveaux cas confirmés contre 69 la veille (−7,2 %) et 102 au 03 octobre (−37,3 %), ainsi que 21 décès contre respectivement 40 et 34. Ces progrès doivent être consolidés, la transmission communautaire demeurant active en Ituri, au Nord-Kivu et au Haut-Uélé, avec des notifications sporadiques à la Tshopo.
- **L'investigation de tous les cas suspects rapportés est maintenue à 100 % dans les provinces ayant transmis leurs données.** Toutefois, le suivi des contacts recule à 81,0 %, contre 83,1 % la veille, et reste inférieur au seuil de 95 %. Le renforcement du suivi quotidien, particulièrement au Nord-Kivu.
- **Maintenir la vigilance et intensifier les interventions dans les foyers actifs**, en renforçant la détection précoce, le transfert rapide des suspects, la PCI, les enterrements dignes et sécurisés et l'engagement communautaire. Adapter prioritairement les capacités d'accueil au Nord-Kivu, où l'occupation des lits atteint 94,9 %, pour garantir des soins précoces, sûrs et de qualité.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Contact :

www.sante.gouv.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.